Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
4ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo

Av. Unisinos, 99 - Bairro: São João Batista - CEP: 93022414 - Fone: (51) 3098-5794 - Balcão Virtual (Whatsapp): 51 99602.8034 - Email: frsaoleo4vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5018197-51.2023.8.21.0033/RS

AUTOR: ROSSANO LUIS MULLER

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

ROSSANO LUIS MULLER ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO)** contra **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, partes qualificadas (evento 1, INIC1). Informou ser portador de "CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE RIM (CID 10: C64)", necessitando de tratamento com "LEVOMALATO DE CABOZANTINIBE 60 mg, 01 comprimido via oral uma vez ao dia, contínuo, até toxidade limitante ou progressão". Pontuou que o réu indeferiu o fornecimento do medicamento. Invocou os dispositivos legais que entendia aplicáveis ao caso. Pediu o deferimento de tutela de urgência para determinar ao réu o fornecimento do tratamento, medida a ser tornada definitiva ao final, com a procedência do pedido. Postulou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.

Foi concedida a gratuidade de justiça, deferida a tutela de urgência e ordenada a citação (evento 4, DESPADEC1).

O réu foi citado eletronicamente, noticiou o cumprimento da liminar (evento 15, EMAIL1) e apresentou contestação (evento 20, CONT1). Afirmou que o medicamento pleiteado não está previsto no Protocolo Oncológico adotado pelo IPE Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada. Referiu que a cobertura de tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, pode levá-lo à insolvência, prejudicando a coletividade associada e afrontando o princípio da isonomia. Pontuou que é um plano de natureza pública, adstrito à regulamentação administrativa. Aludiu que para tratamento de neoplasia maligna do rim estão disponíveis outros medicamentos. Reportou-se à nota técnica 97884, que desaconselha a utilização do fármaco para tratamento de rim. Defendeu a apresentação periódica de laudos atualizados, com reavaliação do caso com o resultado de exame que comprove os benefícios do fármaco na sobrevida livre de progressão da doença melhorada (exame imuno-histoquímico de biópsia ou peça cirúrgica). Requereu a improcedência do pedido.

Houve réplica (evento 25, RÉPLICA1).

As partes foram intimadas para dizer sobre provas (evento 27, DESPADEC1) e nada requereram (evento 31, PET1 e evento 32).

Foi determinada a juntada de laudo médico atualizado pela parte autora (evento 36, DESPADEC1), o que foi atendido no evento 45, LAUDO2, com intimação da parte ré no evento 47, DESPADEC1.

O Ministério Público apresentou parecer (evento 42, PROMOÇÃO1).

Relatei. Passo a decidir.

O processo está apto para julgamento, pois as partes não postularam a produção de outras provas.

Não há controvérsia sobre a relação jurídica entre as partes (a inicial está acompanhada de carteirinha do IPE Saúde em nome do autor - evento 1, OUT7 e não houve contestação no ponto).

Também é incontroverso que o autor apresenta CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE RIM (CID 10: C64), com presença de metástases em pulmão e ósseas, conforme relatório médico acostado. Referiu o médico que o autor já usou Sunitinib e, após progressão de doença óssea, Nivolumab mas, em junho de 2023, apresentou nova progressão de doença óssea e pulmonar (evento 1, LAUDO8).

Conforme prescrição do médico que assiste o autor, ele precisa usar o medicamento LEVOMALATO DE CABOZANTINIBE 60 mg, 01 comprimido via oral uma vez ao dia, de uso contínuo, até toxidade limitante ou progressão.

A controvérsia reside na obrigação do IPE-Saúde de fornecer o medicamento prescrito pelo médico do autor, considerando que tal medicamento não está previsto nas tabelas próprias do Instituto.

O IPE-Saúde é um plano de saúde de natureza pública, gerido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, autarquia estadual criada pela Lei nº 15.144, de 05 de abril de 2018, e regulamentado pela Lei Complementar nº 15.145, de 05 de abril de 2018.

O art. 4.º, §1.º, da Lei Complementar n.º 15.145/2018, define que:

Art. 4.º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.

§ 1.º Ficam excluídos da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais, que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto.

[...]

Diferentemente dos planos privados, que têm sua cobertura prevista por contrato e estão sujeitos à regulamentação e fiscalização da Agência Nacional de Saúde, o IPE-Saúde é um plano de natureza pública, adstrito à regulamentação administrativa, não se lhe aplicando a legislação referente aos direitos do consumidor ou dos demais planos de saúde.

No entanto, o fato de o IPE-Saúde ser um plano de natureza pública não o exime de cumprir sua finalidade precípua, que é a de prestar assistência à saúde dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, conforme estabelecido na legislação que o regulamenta.

O réu sustenta que o medicamento LEVOMALATO DE CABOZANTINIBE 60 mg não está previsto nas Recomendações Técnicas em Oncologia atualmente vigentes, e que, portanto, não estaria obrigado a fornecê-lo ao autor.

No entanto, a interpretação literal e isolada do § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018 não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e à vida, bem como sobre a finalidade precípua do IPE-Saúde, que é a de prestar assistência à saúde dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Embora o IPE-Saúde não se confunda com o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um plano de saúde específico para servidores públicos estaduais, não se pode olvidar que, como entidade pública, está sujeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, dentre os quais o da eficiência, que impõe a busca pela melhor prestação do serviço público, no caso, a assistência à saúde.

Ademais, o art. 2º da Lei Complementar nº 15.144/2018, estabelece:

Art. 2.º Ao Instituto, como gestor do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, compete:

I - assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde, fortalecendo os mecanismos de gestão do Instituto;

II - promover a excelência na assistência à saúde; [...]

Assim, a finalidade precípua do IPE-Saúde é assegurar os princípios fundamentais da promoção à saúde e promover a excelência na assistência à saúde dos servidores públicos estaduais, seus dependentes e pensionistas.

No caso em tela, o autor é portador de CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE RIM (CID 10: C64), com presença de metástases em pulmão e ósseas. O médico que assiste o autor prescreveu o medicamento LEVOMALATO DE CABOZANTINIBE 60 mg, 01 comprimido via oral uma vez ao dia, de uso contínuo, até toxidade limitante ou progressão, como sendo o tratamento mais adequado para o seu caso. Destacou que, enquanto usou medicamentos de primeira e de segunda linha, o autor teve progressão de doença óssea e pulmonar, e que a ausência ou demora no tratamento poderia "permitir o agravo da doença, levando inclusive a internações em CTI, e também pode aumentar o risco de morte" (evento 1, LAUDO8).

O laudo médico atualizado, juntado no evento 45, LAUDO2, atesta que o autor usa Cabozantinibe desde agosto de 2023, com excelente resposta ao tratamento, melhora significativa em seus indicadores clínicos e exames de acompanhamento. O médico afirma que o tratamento com Cabozantinibe tem mostrado eficácia significativa, que os parâmetros clínicos e laboratoriais indicam que a terapia está alcançando os resultados esperados e contribuindo para a estabilização da doença, sendo imperativa a manutenção da continuidade do tratamento até a progressão da doença ou o surgimento de toxicidade limitante:

Atestado Médico

Diagnóstico: Câncer de rim (CID C64)
Tratamento Atual: Cabozantinibe 60mg
Data de Início do Tratamento: Agosto de 2023

A Sr. Rossano vem em uso de Cabozantinibe desde agosto de 2023. O paciente tem apresentado excelente resposta ao tratamento, com melhora significativa em seus indicadores clínicos e exames de acompanhamento.

A adequação do tratamento com Cabozantinibe para a condição da paciente é satisfatória. O medicamento está alinhado com as diretrizes terapêuticas atuais para o CID C64 e demonstrou ser eficaz na abordagem da doença. O estado geral de saúde da paciente é bom. Ele tem tolerado o tratamento de maneira satisfatória, sem evidência de efeitos colaterais severos que comprometam seu bem-estar. Até o momento, o tratamento com Cabozantinibe tem mostrado eficácia significativa. Os parâmetros clínicos e laboratoriais indicam que a terapia está alcançando os resultados esperados e contribuindo para a estabilização da doença.

É imperativo que se mantenha a continuidade do tratamento com Cabozantinibe até a progressão da doença ou o surgimento de toxicidade limitante. A interrupção prematura do tratamento poderia comprometer a eficácia atual e a evolução positiva do quadro clínico. A continuidade do tratamento com Cabozantinibe é imprescindível para a manutenção dos resultados favoráveis alcançados até agora. A suspensão do tratamento poderia levar a uma deterioração do estado clínico da paciente e ao aumento do risco de progressão da doença.

Atenciosamente,

10 de Setembro de 2024

Diante desse quadro, não se mostra razoável a negativa do IPE-Saúde em fornecer o medicamento prescrito pelo médico do autor, sob o fundamento de que tal medicamento não está previsto nas tabelas próprias do Instituto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem se firmado no sentido de que não é facultado ao plano de saúde negar o fornecimento de medicamento para tratamento quimioterápico, sob a justificativa deste não fazer parte da cobertura, pois não cabe ao IPE-Saúde selecionar o tratamento dispensado. Nesse sentido:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE TRATAMENTO SIMILAR POR PARTE DO IPE-SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NESSA INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO NO CASO CONCRETO. - A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, tem por pressupostos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -* ***O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde - mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão - de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato" (AgInt no REsp n. 1.776.448/SP)****. - No caso presente, a parte ré se opôs ao fornecimento do medicamento postulado pelo autor, sob o fundamento de inexistência de cobertura, contudo, conforme acima referido, a recusa motivada na ausência de previsão nas tabelas da autarquia é ilegal. Além disso, a imprescindibilidade e urgência na ministração dos medicamentos é justificado pelo médico assistente da parte autora, profissional credenciado na instituição demandada. -* ***Decisão reformada, determinando ao IPE-SAÚDE a dispensação do fármaco cabozantinibeg, na forma e quantidades recomendadas pelo médico assistente****, sob pena de bloqueio de valores. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51467807120248217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 18-07-2024) (grifei).*
>
> *RMESSA NECESSÁRIA. IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA. RESTRIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO EM TABELAS PRÓPRIAS. LC 15.145/2018. RECUSA ILEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. 1.****O plano de saúde, inclusive no regime de autogestão, não pode excluir de sua cobertura procedimento, medicamento ou material para tratamento de doença prevista no contrato. Jurisprudência do STJ. 2. Afigura-se ilegal a recusa do IPE-SAÚDE em custear procedimentos, exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento à saúde do segurado, ainda que que não constem das suas tabelas. Precedentes deste Tribunal. Hipótese em que há, nos autos, prova da necessidade de fornecimento do tratamento requerido****. 3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Hipótese em que é de ser mantida a verba honorária fixada em primeiro grau. Sentença confirmada em remessa necessária.(Remessa Necessária Cível, Nº 50355085920208210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 18-11-2022) (grifei).*

O argumento de risco à sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde-FAS é argumento genérico e desprovido de comprovação nos autos. A negativa de tratamento essencial à vida e à saúde não pode se basear em alegações financeiras abstratas, mormente quando o segurado contribui regularmente para o plano.

A Nota Técnica 97884 do NATJUS, além de ter sido expedida em 2022, não é vinculante e não pode se sobrepor ao laudo médico que atesta a necessidade do medicamento para o tratamento do autor, especialmente considerando que o tratamento já está sendo realizado desde agosto de 2023, com resultados positivos, conforme atestado pelo médico no laudo atualizado.

Não há ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia, pois o mesmo tratamento pode ser alcançado a outros participantes do plano de saúde que comprovem a necessidade.

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por ROSSANO LUIS MULLER contra IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL para confirmar a tutela de urgência e condenar o réu ao fornecimento do tratamento postulado pelo autor (medicamento LEVOMALATO DE CABOZANTINIBE 60 mg, 01 comprimido via oral uma vez ao dia), durante o período em que o médico assistente declarar a necessidade.

O ente público fica isento do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei 14634/2014). Condeno-o, porém, ao pagamento das despesas processuais, exceto condução do Oficial de Justiça. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 em favor do FADEP.

Interposto recurso de apelação, observando-se o artigo 1.010, §1° do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, subam os autos imediatamente ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado e tudo atendido, baixe-se.

Agendada a intimação das partes e do Ministério Público. Publicação e registro eletrônicos.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA CALDIM DOS SANTOS, Juíza de Direito**, em 11/07/2025, às 15:19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10086370902v40** e o código CRC **06623ced**.